

研究计划书

中国长期护理保险的代际效应与心理健康

博士论文研究计划

2026年7月

目录

- 一、研究背景与意义
- 二、国内外文献综述
- 三、研究目标与研究问题
- 四、研究内容
- 五、研究方法与技术路线
- 六、创新点
- 参考文献

一、研究背景与意义

人口老龄化使失能风险、长期照护需求与家庭照护能力之间的矛盾日益突出。世界卫生组织预计，到 2030 年全球每六人中将有一人年龄达到 60 岁及以上；我国 2024 年末 65 岁及以上人口为 2.20 亿，占总人口的 15.6%（世界卫生组织，2025；国家统计局，2025）。长期护理具有持续时间长、服务组合复杂和费用不确定等特点，单纯依靠家庭成员无偿照护，不仅可能限制失能老年人获得专业服务，也可能挤压照护者的劳动、休息和家庭资源配置。随着家庭规模缩小、人口流动增加和代际同住方式变化，如何在家庭责任与社会保障之间合理分担长期照护风险，已经成为中国社会保障体系建设中的重要议题。

我国长期护理保险经历了由地方探索、国家试点到全面建制的政策演进。人力资源和社会保障部办公厅于 2016 年印发《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》，在 15 个城市开展国家试点，并将吉林、山东列为重点联系省份；国家医保局、财政部于 2020 年新增 14 个试点地区，继续探索筹资、待遇、失能评估、服务供给和经办管理机制。2026 年 3 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快建立长期护理保险制度的意见》，标志着制度从试点探索转向全面建制，并提出用三年左右时间建立覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的长期护理保险制度（人力资源和社会保障部办公厅，2016；国家医疗保障局、财政部，2020；中共中央办公厅、国务院办公厅，2026）。本研究的因果识别窗口仍聚焦历史试点期，地区分期实施以及参保资格差异为评估制度影响提供了准自然实验条件；当前制度进展用于说明研究的现实意义，不倒推改变历史处理状态。

现有政策评价多以医疗服务利用、照护安排、家庭支出或劳动供给为结果变量。心理健康同样值得独立研究：失能、疼痛、社会隔离、照护质量不稳定及对家庭形成负担的感受，均可能影响老年人的抑郁症状和主观福祉；专业照护与风险共济则可能通过缓解照护不确定性、释放家庭资源和改善社会互动而产生心理收益。因此，若仅计算医疗费用或护理服务，可能遗漏长期护理保险的重要福利维度。

长期照护决策还具有明显的家庭联结。父母是否获得正式照护会改变成年子女的照护时间、就业约束、经济转移和心理压力；家庭资源重新配置又可能影响孙辈的教育投入与发展机会。由此，长期护理保险的受益边界可能超出直接符合待遇条

件的老年人。将第一代老年人、第二代成年子女与第三代学龄期孙辈纳入统一分析，有助于从家庭资源配置和代际传递角度理解社会保险的完整福利效应。

本研究的理论意义在于，把长期护理保险的风险共济功能与家庭内部时间、收入和情感资源配置联系起来，构建“制度覆盖—照护替代与资源释放—心理健康及代际福利”的分析框架，并区分直接效应、机制效应与跨代外溢。政策意义在于，为制度成本收益评价提供比直接参保人更完整的观察单位，识别哪些家庭更可能从正式照护中受益，并为待遇设计、服务供给以及长期护理保险与医疗、养老、儿童发展政策的衔接提供经验依据。

二、国内外文献综述

（一）长期护理保险的经济效应

德国、日本、韩国等较早建立或扩展公共长期照护制度的国家，为研究正式照护对服务利用、家庭支出和照护供给的影响提供了制度场景。相关研究的共同逻辑是，社会保险降低符合条件者使用正式照护的价格，并可能替代部分家庭照护，但替代程度取决于现金或实物给付方式、服务可及性及家庭偏好。因此，同一制度可能同时带来正式服务使用增加、灾难性照护支出风险下降和家庭照护结构变化，其净福利不能由单一指标判断。

中国长期护理保险研究主要利用地方试点的时间差异，分析医疗服务、照护方式、消费和劳动供给。此类研究说明试点具有准实验评价价值，但各地在覆盖人群、待遇资格、筹资和服务目录上存在差异，政策变量不能简单等同于实际待遇领取。对于微观调查数据，更可行的做法往往是识别参保资格或制度暴露的意向治疗效应，并通过政策口径变化和样本限制检验稳健性。

（二）长期护理保险与心理健康

老年心理健康受到身体功能、经济安全、社会联系、家庭陪伴和照护质量的共同影响。长期护理保险可能通过获得专业照护、减少未满足照护需求和降低费用不确定性改善心理健康，也可能因严格失能认定、服务供给不足或家庭互动减少而呈

现有限甚至相反的效应。已有证据更多关注身体健康、医疗利用和照护负担，心理健康常作为附带结果，较少同时检验具体症状、动态效应与家庭机制。

心理健康测量还涉及跨调查可比性。CFPS 与 CHARLS 均包含抑郁症状题项，但调查对象、题目版本和调查实施方式并非完全相同。将两项调查用于互补验证时，应统一量表方向和可比题项，并保留调查来源控制；在无法完全协调时，应分别估计后比较结论，而不宜机械合并。这样才能区分政策效应与测量差异。

（三）长期护理保险与家庭福利

家庭是长期照护生产和资源配置的核心单位。正式照护供给可能减少成年子女的时间约束，使其增加就业或调整工作时长，同时降低因父母失能带来的心理压力；但若正式服务与家庭照护互补，子女的照护投入未必下降。保险也可能改变父母与子女之间的经济转移、家庭消费结构和居住安排。由此，第二代效应的方向需要实证识别，不能由第一代结果直接推断。

第三代效应更少受到关注。父母一代照护祖辈的时间下降，可能释放对子女陪伴和教育投入；家庭照护支出风险下降，也可能增加教育消费。相反，若待遇不足以覆盖照护成本，家庭资源约束仍可能存在。孙辈的缺课、教育投入和学习表现属于不同维度，需分别界定结果变量，并将其解释为家庭资源重新配置的可能表现，而不是预设的制度收益。

（四）研究不足

现有研究至少存在四方面不足。第一，对长期护理保险心理健康效应的机制讨论不够系统，难以区分照护改善、经济保障和家庭互动渠道。第二，异质性分析有时停留于事后分组，缺少与理论机制相对应的预设维度。第三，多数研究以直接受益老年人或单一照护者为边界，对成年子女和孙辈的连续传导缺乏统一框架。第四，在分期实施背景下，传统双向固定效应估计可能混合不同处理批次和时期的效应，需使用适合异质处理效应的估计与诊断方法（Goodman-Bacon, 2021；Sun 和 Abraham, 2021；Callaway 和 Sant'Anna, 2021）。本研究拟在一致的政策口径和家庭联结框架下，同时评估第一代心理健康、第二代福利与第三代教育结果，并对识别假设开展系统检验。

三、研究目标与研究问题

本研究旨在识别中国长期护理保险试点对老年人心理健康的因果影响，解释其作用机制与人群差异，并考察影响是否沿家庭关系扩展至成年子女和学龄期孙辈。研究将把政策资格暴露与实际待遇领取加以区分，以意向治疗效应作为主要解释对象；在数据允许时，进一步讨论不同覆盖口径和政策强度下的结果。

围绕上述目标，本研究提出四个核心问题：

1. 长期护理保险资格覆盖是否改善 60 岁及以上老年人的心理健康，影响是否随政策实施时间而变化？
2. 该影响是否因老年人的照护需求、经济资源、家庭支持和地区服务供给而不同？
3. 正式照护可及性、家庭消费与经济转移、退休和劳动供给以及家庭照护安排是否构成作用渠道？
4. 长期护理保险是否对成年子女的心理健康与劳动供给、以及学龄期孙辈的教育参与和家庭教育投入产生福利外溢？

据此提出以下可检验假设：

H1： 长期护理保险资格覆盖将降低老年人的抑郁症状；该效应在政策实施后逐步显现，但具体幅度和持续性由数据检验。

H2： 老年人的照护需求、经济约束和可获得的家庭支持将调节政策效应；正式照护需求较高且家庭替代资源较少的群体，预期心理健康改善更明显。

H3： 长期护理保险将通过改善正式照护可及性、缓解家庭预算约束、调整劳动与退休决策以及改变代际经济转移和照护投入，影响老年人的心理健康。

H4： 长期护理保险释放的照护时间与家庭资源将外溢至后代，表现为成年子女心理压力缓解和劳动配置调整，以及孙辈教育参与或家庭教育投入改善；各维度的方向和大小分别检验。

四、研究内容

（一）研究任务一：评估老年人心理健康效应

本研究拟首先整理国家及地方试点政策，按城市、启动年份、基本医保类型和实际覆盖范围构建政策资格指标。研究拟以 60 岁及以上老年人第一代样本，以 CES-D 可比题项构造抑郁症状总分及症状维度，估计长期护理保险资格覆盖的平均意向治疗效应和动态效应。研究拟分别使用 CFPS 和 CHARLS 进行估计，并在变量可比条件满足时开展协调样本分析，以避免调查差异被误解为政策影响。

（二）研究任务二：识别效应异质性

本研究拟依据理论预先设定异质性维度，包括功能受限或自评健康所反映的照护需求、家庭收入所反映的经济约束、婚姻状况和子女数量所反映的家庭支持，以及城乡属性和地区照护服务条件。研究拟通过交互项或分组估计比较不同群体的效应，同时报告组间差异检验，避免仅凭子样本显著性判断异质性。若样本量不足，研究拟合并相关维度或将结果作为探索性证据。

（三）研究任务三：检验作用机制

本研究拟围绕“正式照护替代—家庭资源释放—心理健康”路径检验机制。第一，拟考察可识别的正式照护使用、非正式照护时间或照护安排变化；第二，拟分析非医疗消费、医疗与照护支出等家庭预算结果；第三，拟检验老年人的退休、就业状态和工作时长；第四，拟考察父母与成年子女之间的经济转移和居住、联系等家庭互动。机制分析将明确时间顺序，并把机制变量视为中间结果，不以单个中介回归直接宣称完整因果链。

（四）研究任务四：评估第二代影响

本研究拟利用 CFPS 和 CHARLS 中的家庭关系信息，将第一代老年人与 20 至 60 岁的成年子女匹配，构建第二代样本。研究拟检验父母所在地区及其资格类型对应的政策暴露，对成年子女抑郁症状、就业、工作时长和过度劳动等结果的影响。

研究拟区分同住与不同住子女、主要照护者与其他子女，并控制可能同时作用于当地劳动力市场的城市 and 年份因素，以判断结果更符合照护时间释放还是一般地区政策冲击。

（五）研究任务五：评估第三代影响

本研究拟进一步将第一代与 7 至 17 岁的学龄期孙辈建立家庭联结，考察祖辈长期护理保险暴露是否影响孙辈缺课、校外教育参与、教育时间和家庭教育支出等结果。研究拟以家庭资源约束和父母时间配置为主要解释路径，并检验第二代照护与劳动变化是否与第三代结果同步。鉴于三代匹配可能导致样本缩小和选择性增强，研究拟报告样本形成过程、家庭关系匹配成功率及基线特征差异，并将第三代结论限定在可观测的联结样本范围内。

五、研究方法与技术路线

（一）数据来源与样本边界

本研究拟使用中国家庭追踪调查（CFPS）和中国健康与养老追踪调查（CHARLS）。CFPS 提供家庭成员关系、成人与儿童信息，适合建立三代联结；CHARLS 聚焦 45 岁及以上人群，提供较丰富的健康、功能与家庭支持信息（谢宇和胡婧炜，2014；Zhao 等，2014）。政策数据拟来自 2016 年和 2020 年国家试点文件、地方实施办法及可追溯的官方发布日期。第一代样本拟限定为 60 岁及以上老年人，第二代拟限定为 20 至 60 岁成年子女，第三代拟限定为 7 至 17 岁学龄期孙辈。最终调查轮次和城市范围将由政策时点、变量可比性及数据授权情况共同确定，不预设未经复核的样本量。

（二）变量设计

核心解释变量为个体是否在某年依据所在城市、政策启动时间及基本医保类型具备长期护理保险资格。该变量主要衡量制度暴露而非实际待遇领取，故基准系数解释为意向治疗效应。第一代主要被解释变量为统一方向后的 CES-D 抑郁症状指标

；第二代结果包括抑郁症状、就业与工作时长；第三代结果包括教育参与、时间投入和家庭教育支出。控制变量拟包括年龄、性别、婚姻、教育、户口、家庭结构、家庭经济状况以及城市层面的经济和公共服务特征。可能受政策影响的变量不作为基准控制变量，以免引入“坏控制”。

（三）基准模型

本研究拟利用试点分期实施及资格差异构建双重差分模型。设个体或家庭成员 (i) 位于城市 (c)、年份为 (t)，基准模型为：

$$Y(i,c,t) = \beta[LTCI\text{Eligible}(i,c) \times \text{Post}(c,t)] + \theta X(i,c,t) + \mu(c) + \lambda(t) + \varepsilon(i,c,t)$$

其中， $Y(i,c,t)$ 为各代结果变量， $LTCI\text{Eligible}(i,c) \times \text{Post}(c,t)$ 表示资格群体在当地政策实施后的暴露，城市固定效应和年份固定效应分别控制不随时间变化的地区差异与共同时间冲击。标准误拟在政策实施层级聚类；在可行时加入个体固定效应、调查来源与城市交互项。由于政策分期实施，传统双向固定效应仅作为基准描述，主要结论需经异质处理效应稳健方法验证。

（四）七类补充识别与检验

1. **平行趋势检验。** 本研究拟使用事件研究绘制实施前后的动态系数和置信区间，重点检验政策前系数是否整体接近零，并结合处理组、对照组原始趋势判断识别假设，而不把“前置项不显著”视为充分证明。
2. **一般稳健性检验。** 本研究拟更换政策覆盖口径、量表构造、年龄边界和样本限制，加入个体固定效应与地区线性趋势，排除部分实施或政策时点不清的地区，并考察同期相关政策是否驱动结果。聚类推断将遵循政策层级，必要时采用适合聚类数量的推断方法（Bertrand 等，2004）。
3. **Bacon decomposition。** 本研究拟分解分期处理下双向固定效应所使用的两两比较及其权重，诊断早期处理组被用作后期处理组对照以及负权重等问题；该分解用于解释基准估计来源，而非作为新的因果估计量（Goodman-Bacon，2021）。
4. **Sun-Abraham DID。** 本研究拟按首次处理批次估计队列特定的动态效应，再进行适当聚合，以避免传统事件研究在处理效应随批次或时间变化时受到污染（Sun 和 Abraham，2021）。

5. **Callaway-Sant'Anna DID。** 本研究拟估计“处理批次—时期”平均处理效应，并分别按事件时间、批次和总体进行聚合，以从另一组识别与聚合规则验证分期处理结果（Callaway 和 Sant'Anna，2021）。
6. **安慰剂检验。** 本研究拟使用虚假实施年份、随机置换试点地区或不应受影响的结果变量构造伪政策；若伪政策反复产生与基准相近的效应，则需重新审视趋势、推断或遗漏冲击，而不能据此支持原假设。
7. **三重差分。** 本研究拟利用城市、实施前后与参保资格或高照护需求维度构建三重差分，进一步剔除试点城市中同时影响所有居民的共同冲击。该方法仅在第三维度有明确制度含义且趋势假设可辩护时使用，并报告相应的前趋势证据。

（五）技术路线

研究将依次完成政策文本编码与数据口径统一、三代家庭关系匹配、描述性统计与样本选择诊断、基准 DID 与动态效应估计、七类补充识别、异质性与机制分析、第二代和第三代外溢估计。所有政策时点和资格规则均保留来源记录，数据清理与估计过程使用可复现代码完成。结果解释将区分制度资格暴露、实际参保和待遇领取，避免把意向治疗效应外推为所有待遇享受人的平均效果。

六、创新点

第一，本研究拟从多代福利视角扩展长期护理保险评价边界，在统一的家庭联结框架中同时考察老年人、成年子女与学龄期孙辈，比较直接受益、照护者外溢和家庭资源跨代传递，补充仅以直接参保人核算制度收益的视角。第二，本研究拟将老年心理健康作为核心福利结果，结合症状维度、动态效应和理论预设的异质性，系统分析正式照护、经济保障、劳动退休与代际互动等可能渠道，同时避免将中介相关性直接解释为完整因果机制。第三，本研究拟针对中国试点分期实施和覆盖规则差异，统一政策资格口径，并结合 Bacon decomposition、Sun-Abraham DID、Callaway-Sant'Anna DID、安慰剂与三重差分等方法验证识别结果，从而提高多代效应估计的透明度与可解释性。

参考文献

- Bertrand, M., Duflo, E., and Mullainathan, S. 2004. How Much Should We Trust Differences-in-Differences Estimates? *The Quarterly Journal of Economics*, 119(1): 249-275. <https://doi.org/10.1162/003355304772839588>.
- Callaway, B., and Sant'Anna, P. H. C. 2021. Difference-in-Differences with Multiple Time Periods. *Journal of Econometrics*, 225(2): 200-230. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001>.
- Goodman-Bacon, A. 2021. Difference-in-Differences with Variation in Treatment Timing. *Journal of Econometrics*, 225(2): 254-277. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2021.03.014>.
- Sun, L., and Abraham, S. 2021. Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies with Heterogeneous Treatment Effects. *Journal of Econometrics*, 225(2): 175-199. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.09.006>.
- Xie, Y., and Hu, J. 2014. An Introduction to the China Family Panel Studies (CFPS). *Chinese Sociological Review*, 47(1): 3-29. <https://doi.org/10.2753/CSA2162-0555470101>.
- Zhao, Y., Hu, Y., Smith, J. P., Strauss, J., and Yang, G. 2014. Cohort Profile: The China Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS). *International Journal of Epidemiology*, 43(1): 61-68. <https://doi.org/10.1093/ije/dys203>.
- 国家医疗保障局、财政部，2020：《关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》（医保发〔2020〕37号）。
- 人力资源和社会保障部办公厅，2016：《关于开展长期护理保险制度试点的指导意见》（人社厅发〔2016〕80号）。
- 国家统计局，2025：《中华人民共和国 2024 年国民经济和社会发展统计公报》。
- 世界卫生组织，2025：《Ageing and Health》事实清单。
- 中共中央办公厅、国务院办公厅，2026：《关于加快建立长期护理保险制度的意见》。
- 谢宇、胡婧炜，2014：《中国家庭追踪调查：理念与实践》，《社会》第 34 卷第 2 期，第 1-32 页。